

 **Exemple fictif — modèle pédagogique, à ne pas déposer.** Parcours, situations, prénoms et établissements sont **entièrement inventés**. Ce document montre à quoi peut ressembler un dossier de validation VAE pour le DEAS, afin de servir de repère de structure et de ton. Un vrai dossier se construit à partir de **ton** expérience réelle, au format France VAE, avec ton accompagnateur. Vérifie toujours les modalités sur france-vae.gouv.fr.

Dossier de validation — VAE

Diplôme d'État d'Aide-Soignant·e
(arrêté du 10 juin 2021)

Candidat·e : *[Prénom NOM]*

Expérience : *[ex. 3 ans d'auxiliaire de vie / agent de service en EHPAD]*

Session : *[année]*

Document anonymisé — aucun nom réel de personne accompagnée, de collègue ou d'établissement.

Sommaire

Introduction — mon parcours	1
Situation 1 — Accompagnement de la toilette d'une résidente qui refuse	2
Situation 2 — Repérage d'une aggravation de l'état clinique	3
Situation 3 — Aide au repas et prévention de la fausse route	4
Situation 4 — Entretien de l'environnement et prévention du risque infectieux	5
Tableau de couverture des 11 compétences	6
Conclusion	6

Introduction — mon parcours

J'exerce depuis trois ans en EHPAD, d'abord comme agent de service puis comme auxiliaire de vie, auprès de personnes âgées dépendantes, souvent désorientées. Au fil de cette expérience, j'ai développé des compétences que je souhaite faire reconnaître par la VAE : accompagnement des actes essentiels, repérage des risques, participation aux soins, communication, entretien de l'environnement et transmissions.

J'ai choisi quatre situations de travail vécues, représentatives de mon activité, qui me permettent de démontrer l'ensemble des compétences du référentiel. Elles sont décrites selon la même trame : contexte, ce que j'ai fait concrètement, difficultés rencontrées, résultat.

Situation 1 — Accompagnement de la toilette d'une résidente qui refuse

Compétences mobilisées : 1, 2, 6

Contexte. Dans l'unité protégée où je travaille, j'accompagne le matin la toilette de Mme B., 84 ans, atteinte de troubles cognitifs, très pudique, qui refuse souvent le soin quand on va trop vite.

Ce que j'ai fait. Je suis entrée doucement, je me suis présentée et je me suis assise un instant à côté d'elle. J'ai parlé d'une photo sur sa table de nuit pour créer le lien, puis j'ai annoncé chaque geste avant de le faire, en préservant son intimité (une partie du corps découverte à la fois) et en la laissant tenir le gant. J'ai surveillé l'état de sa peau (points d'appui) pendant le soin.

Difficultés. Mme B. a commencé à s'agiter au moment de laver le dos. J'ai arrêté, je l'ai rassurée, j'ai attendu quelques instants avant de reprendre plus doucement.

Résultat. La toilette a été réalisée sans contrainte ni cri. J'ai transmis à l'IDE une rougeur repérée au sacrum et noté le refus initial dans les transmissions.

Situation 2 — Repérage d'une aggravation de l'état clinique

Compétences mobilisées : 3, 4, 10

Contexte. Un après-midi, M. D., 79 ans, me semble inhabituellement somnolent et rouge lors de mon passage.

Ce que j'ai fait. J'ai pris ses constantes : température 38,9 °C, pouls rapide, saturation abaissée. J'ai observé les autres signes (confusion, diminution des urines). J'ai immédiatement alerté l'IDE en lui transmettant les valeurs mesurées et mes observations, et je suis restée auprès de M. D. en le surveillant.

Difficultés. M. D. ne pouvait pas exprimer clairement ce qu'il ressentait ; j'ai dû m'appuyer sur l'observation.

Résultat. L'IDE a pu réagir rapidement (avis médical, hydratation). J'ai tracé les constantes et l'heure de l'alerte dans le dossier de soins pour assurer la continuité.

Situation 3 — Aide au repas et prévention de la fausse route

Compétences mobilisées : 1, 2, 5

Contexte. J'aide au repas Mme L., qui présente des troubles de la déglutition et pour laquelle une texture modifiée est prescrite.

Ce que j'ai fait. Je l'ai installée bien assise, tête légèrement penchée en avant, dans un environnement calme. J'ai vérifié la texture, donné de petites quantités en respectant son rythme, en m'assurant qu'elle avait avalé avant la bouchée suivante. Je suis restée attentive aux signes de fausse route.

Difficultés. Mme L. voulait aller vite ; je l'ai rassurée et j'ai maintenu un rythme sécurisé.

Résultat. Le repas s'est déroulé sans fausse route. J'ai transmis la quantité mangée et l'installation efficace pour l'équipe.

Situation 4 — Entretien de l'environnement et prévention du risque infectieux

Compétences mobilisées : 8, 9, 11

Contexte. Je réalise l'entretien quotidien de la chambre et la réfection du lit d'un résident, en respectant les protocoles de bionettoyage du service.

Ce que j'ai fait. J'ai appliqué les précautions standard (hygiène des mains, gants), respecté le circuit du plus propre au plus sale et le sens des surfaces, utilisé les produits selon le protocole. J'ai vérifié le bon fonctionnement du matériel.

Difficultés. J'ai constaté qu'un distributeur de solution hydro-alcoolique était vide et défectueux.

Résultat. J'ai signalé le dysfonctionnement au cadre et tracé l'anomalie ; le matériel a été remplacé. J'ai ainsi contribué à la prévention du risque infectieux et à la démarche qualité.

Tableau de couverture des 11 compétences

Compétence	Situation(s)
1 — Accompagner les actes essentiels, personnaliser	1, 3
2 — Identifier les risques, prévenir	1, 3
3 — Évaluer l'état clinique	2
4 — Mettre en œuvre des soins adaptés	2
5 — Mobilité / installation	3
6 — Communication avec la personne et l'entourage	1
7 — Informer / former les pairs	<i>à compléter (ex. accueil d'un stagiaire)</i>
8 — Entretien des locaux et du matériel	4
9 — Repérer les anomalies d'entretien	4
10 — Rechercher / transmettre les données	2
11 — Organiser, coopérer, démarche qualité	4

Dans un vrai dossier, veille à ce que **les 11 compétences** soient couvertes : ici la compétence 7 reste à illustrer par une situation (par exemple l'accompagnement d'un·e stagiaire).

Conclusion

Ces situations reflètent mon activité quotidienne et l'évolution de ma pratique. La VAE me permettrait de faire reconnaître ces compétences par le diplôme, et de poursuivre mon engagement auprès des personnes accompagnées avec un cadre professionnel renforcé.

Fin du document — exemple fictif à usage pédagogique. À ne pas déposer en l'état.